

1) Una paciente de 25 años, con antecedente de haber iniciado su vida sexual a los 14 años y, desde entonces, mantener relaciones sexuales, con múltiples parejas, sin utilización de métodos de barrera, se realiza un PAP que es informado como lesión de alto grado. Además, se realiza tipificación de virus papiloma humano, que muestra serotipo de bajo grado. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar nuevo PAP en 6 meses
- b) Solicitar nuevo PAP en 6 años
- ☒ c) Realizar colposcopia y eventual biopsia
- d) Realizar conización cervical
- e) Realizar histerectomía

2) Una paciente de 53 años, en terapia de remplazo hormonal combinada oral, desde hace 6 meses, presenta metrorragia de 3 días de evolución, escasa. Su examen físico no tiene alteraciones y en la especuloscopia se aprecian restos de sangre en el orificio cervical externo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Atrofia endometrial
- b) Pólipo endometrial
- ☒ c) Hiperplasia endometrial
- d) Cáncer de endometrio
- e) Metrorragia disfuncional

3) Una paciente de 56 años de edad presenta metrorragia abundante, que se maneja con legrado. Se envía a biopsia, que es informada, como hiperplasia endometrial compleja, sin atipias. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Controlar con ecografía en 6 meses
- b) Solicitar resonancia magnética nuclear de pelvis
- ☒ c) Iniciar progestágenos orales
- d) Realizar histerectomía total
- e) Iniciar estrógenos orales

4) Una paciente de 34 años, multipara, embarazada de 36 semanas, presenta pérdida de líquido abundante por los genitales, hace una hora. La especuloscopia muestra cuello cerrado, con salida de líquido y la ecografía obstétrica muestra disminución del líquido amniótico, con presentación cefálica. El registro no estresante es reactivo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Mantener conducta expectante
- b) Administrar corticoides
- ☒ c) Interrumpir el embarazo
- d) Esperar 24 horas para inicio espontáneo del trabajo de parto
- e) Administrar antibióticos

5) Una paciente de 27 años, cursando un embarazo de 32 semanas, consulta por dinámica uterina, con contracciones dolorosas 2 en 10 minutos, que no han cedido al uso de antiespasmódicos, ni al de nifedipino. Al examen físico presenta temperatura 38,0 grados Celsius, PA: 120/80 mmHg, FC: 80x'. Su tacto vaginal tiene un cuello cerrado, duro y posterior. El monitoreo fetal muestra latidos a 145x'. Se solicita un hemograma muestra glóbulos blancos: 11.000 por mm3. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Dejar a evolución espontánea
- b) Solicitar perfil biofísico
- c) Realizar cesárea
- d) Realizar amniocentesis
- e) Administrar tocolíticos de segunda línea

6) Una paciente de 37 años, cursando embarazo de 29 semanas, se realiza un test de tolerancia a la glucosa oral, de 75 gramos, que muestra glicemia basal de 86 mg/dl y postcarga de 139 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar dieta hipoglucídica y controlar con glicemias seriadas
- b) Solicitar hemoglobina glicosilada
- c) Iniciar metformina
- d) Repetir el examen a las 32 semanas
- e) Mantener el control habitual del embarazo

7) Una paciente de 23 años, primigesta, cursando embarazo de 13 semanas, se realiza determinación de grupo sanguíneo, que es informada como AB, Rh(-), Du (+). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar doppler de arteria cerebral media fetal
- b) Solicitar Coombs indirecto a las 18 semanas
- c) Administrar Rhogam a las 28 semanas
- d) Determinar grupo y Rh del padre
- e) Mantener control habitual del embarazo

8) Una paciente de 41 años, cursando un embarazo de 11 semanas, se realiza una ecografía transvaginal, que muestra translucencia nuchal de 6 mm (VN: menor a 3 mm) y ausencia de hueso nasal. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

- a) Ofrecer aborto por causa genética
- b) Mediciones ecográficas seriadas de fémur
- c) Repetir el examen a las 14 semanas
- d) Estudio genético de DNA fetal libre en sangre materna
- e) Niveles plasmáticos de HCG

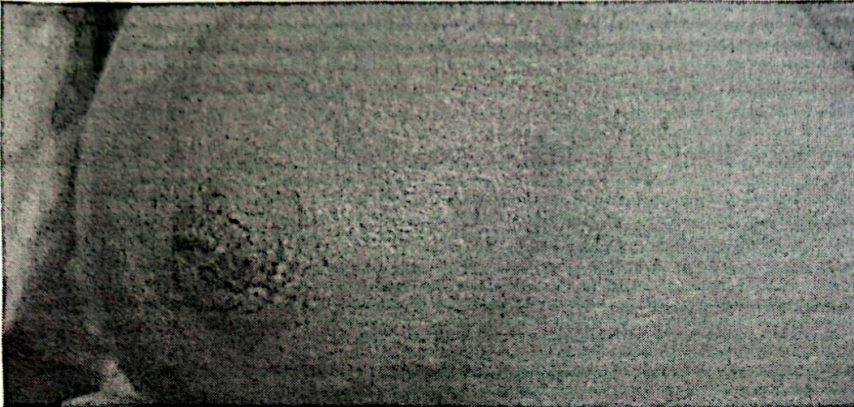
9) Una mujer de 52 años presenta reglas irregulares, desde hace 8 meses, asociadas a bochornos frecuentes, con calor, enrojecimiento de la cara, sudoración nocturna y dificultades para dormir. ¿Cuál es la indicación más adecuada para el manejo de los síntomas de esta paciente?

- a) Fitoestrógenos
- b) Antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina
- c) Terapia de reemplazo hormonal combinada cíclica
- d) Estrógenos solos continuos
- e) Progestágenos solos continuos

10) Una paciente de 30 años, con antecedente de embarazo de 7 semanas de amenorrea, se realiza una ecografía transvaginal, que muestra útero con presencia de saco gestacional de 18 mm de diámetro, sin presencia de embrión. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar laparoscopia
- ☒ b) Solicitar nueva ecografía en 7 días
- c) Solicitar niveles seriados de HCG
- d) Realizar legrado uterino
- e) Administrar progesterona

11) Una mujer puérpera hace 5 semanas, dando lactancia materna exclusiva, consulta por dolor y enrojecimiento del pezón derecho. Al examen físico se muestra lo siguiente (fuente: <https://pezonesinvertidos.com/>):



¿Cuál es el tratamiento de elección?

- a) Mupirocina tópica
- b) Clotrimazol tópico
- c) Óxido de zinc tópico
- ☒ d) Corregir la técnica de lactancia materna ✓
- e) Betametasona tópica

12) Una paciente de 15 años, con menarquia a los 14 años, consulta por atraso menstrual de 2 meses. No tiene vida sexual. Su examen físico segmentario no muestra alteraciones y tiene desarrollo mamario y genital acorde a su edad. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☒ a) Pedir niveles plasmáticos de TSH y prolactina
- b) Solicitar ecografía transvaginal
- c) Realizar histerosonografía
- d) Iniciar anticonceptivos orales
- e) Dar progesterona oral, si el atraso dura un mes más

13) Una paciente de 35 años, cursando un embarazo de 38 semanas, consulta por contracciones uterinas, que se constatan como 3-4 cada 10 minutos. Al tacto vaginal presenta 10 cm de dilatación, membranas rotas y cabeza fetal en espinas 0, en variante mentoiliaca derecha posterior. El monitoreo fetal resulta tranquilizador. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Dejar a evolución espontánea y controlar en una hora
- b) Hacer fórceps
- c) Realizar vaccum de la cabeza fetal
- d) Realizar amnioinfusión con rotación manual
- ☒ e) Hacer cesárea de urgencia

14) Una paciente de 25 años presenta un aborto espontáneo, hace 2 meses, que no requirió de legrado. Actualmente presenta metrorragia de 7 días de evolución, que en la especuloscopia se aprecia que sale del orificio cervical externo. Su HCG resulta 135.000 UI/L. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra útero aumentado de tamaño, con contenido uterino irregular y múltiples vesículas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar metotrexato
- b) Esperar evolución espontánea
- ☒ c) Realizar legrado
- d) Realizar resonancia magnética nuclear de pelvis
- e) Realizar histerectomía

15) Una paciente de 25 años, cursando con embarazo de 30 semanas, con antecedente de epilepsia hace 1 año, presenta crisis convulsivas tónico-clónicas, desde hace una hora. Al examen físico se aprecia edema de extremidades inferiores, FC: 87x' y PA: 160/100 mmHg. La ecografía obstétrica muestra feto vivo. ¿Cuál es la primera medida?

- a) Administrar nifedipino ✓
- b) Administrar fenobarbital
- ☒ c) Administrar sulfato de magnesio ✓
- d) Administrar diazepam ?
- e) Administrar misoprostol

16) Una paciente de 15 años, sin antecedentes de importancia, presenta dolor pélvico muy intenso, en relación a la menstruación, que la hace faltar al colegio. Su menarquia fue hace un año y presenta reglas III-V / 30-35. El tratamiento de elección es:

- ☒ a) Ácido mefenámico
- b) Anticonceptivos orales
- c) Dienogest
- d) Paracetamol
- e) Ácido tranexámico

17) Una paciente de 41 años, multípara de 2, con antecedente de HTA, en tratamiento con metildopa, cursando un nuevo embarazo de 12 semanas. En chequeo ecográfico obstétrico, se pesquisa elevación de la resistencia de las arterias uterinas. La conducta más adecuada es:

- ☒ a) Cambiar el tratamiento antihipertensivo
- b) Iniciar ácido acetilsalicílico *paracetamol*
- c) Iniciar L-arginina
- d) Iniciar heparina de bajo peso molecular
- e) Realizar nuevo Doppler de arterias pélvicas a las 16 semanas

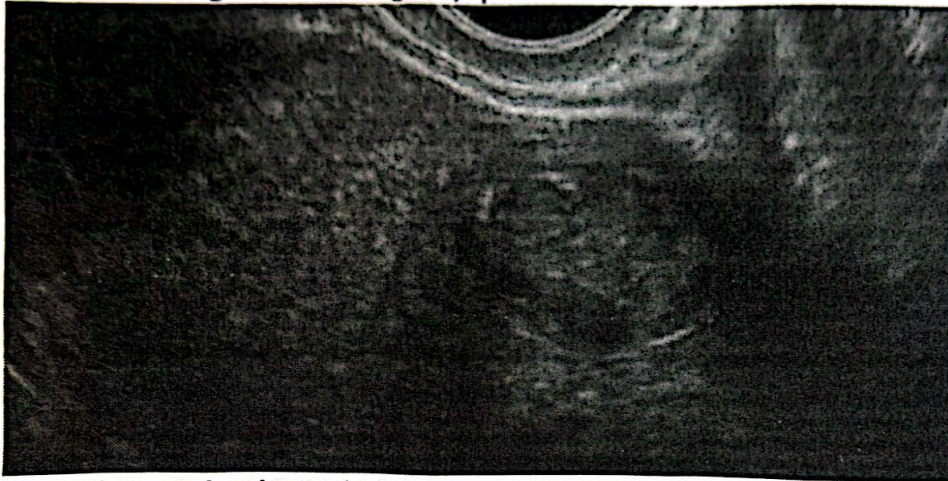
18) Una mujer de 25 años, cursando un embarazo de 38 semanas, se realiza ecografía obstétrica, con feto creciendo en percentil 5 para la edad gestacional y oligoamnios. La ecografía Doppler muestra dilatación de la arteria cerebral media, sin otras alteraciones de la hemodinamia fetal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☒ a) Inducir el parto
- b) Realizar test de tolerancia a las contracciones
- c) Realizar cesárea
- d) Realizar monitoreo fetal no estresante
- e) Repetir el Doppler en 1 semana

19) Una paciente de 56 años está en tratamiento con terapia de reemplazo hormonal, hace 2 años, con estrógenos y progestágenos combinados, continuos. Consulta por metrorragia desde hace 4 meses, que ocurren cada 15 a 20 días y duran 3 a 5 días, autolimitado. Se realiza una ecografía transvaginal que muestra un mioma de 4 cm, con endometrio de 8 mm de grosor. No tiene otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Cambiar la terapia de reemplazo combinada cíclica
- b) Solicitar una resonancia magnética nuclear de pelvis
- c) Realizar histeroscopia -
- d) Realizar biopsia de endometrio
- ☒ e) Realizar histerectomía -

20) Una paciente de 48 años, esterilizada hace 4 años, acude a control ginecológico, en que se realiza una ecografía transvaginal, que se muestra a continuación:



La conducta más adecuada es:

- a) Ulipristal
- b) Histerectomía total transvaginal
- ☒ c) Histerectomía subtotal -
- d) Miomectomía
- e) Ecografía en 6 meses

21) Una paciente de 67 años acude a control ginecológico, en el cual se le palpa un tumor anexial derecho. Se solicita ecografía transvaginal que muestra un tumor multiloculado, de 6 cm de diámetro. El Ca-125 resulta 50 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada? ↗

- a) Iniciar anticonceptivos orales y solicitar nueva ecografía en 3 meses
- b) Realizar punción-aspiración de la lesión y enviar a biopsia citológica
- c) Realizar seguimiento con Ca-125
- d) Tranquilizar a la paciente e indicar control ecográfico en 6 a 12 meses ✕
- ☒ e) Realizar anexectomía con biopsia quirúrgica

22) Una paciente de 45 años, con antecedente de ovario poliquístico, presenta metrorragia de una semana de evolución. Su prueba de embarazo es negativa y se solicita ecografía transvaginal, que muestra endometrio de 20 mm de grosor, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TSH y prolactina
- b) Solicitar prueba de progesterona
- ☒ c) Iniciar anticonceptivos orales -
- d) Indicar progestágenos orales solos
- e) Realizar biopsia Pipelle

23) Una paciente de 38 años se realiza un PAP, que es informado como "displasias celulares escamosas de bajo grado". Se solicita una colposcopia, que visualiza una lesión acetoblanca, la que se biopsia, demostrando presencia de "Neoplasia Intraepitelial grado I". ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar histerectomía
- b) Indicar estrógenos locales
- c) Realizar cono frío
- d) Realizar cono con asa LEEP
- e) Observar evolución

24) Una paciente de 50 años se realiza un PAP, que muestra displasias glandulares de alto grado. Se realiza colposcopia, con curetaje endocervical y biopsia, que no muestra alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar biopsia endometrial ✓
- b) Realizar cono frío
- c) Realizar cono con asa LEEP
- d) Realizar histerectomía
- e) Observar evolución

25) Una mujer de 45 años se realiza una mamografía, que es informada como Birrads 2, por presencia de una lesión calcificada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar control mamográfico en un año ✓
- b) Solicitar ecografía de mamas —
- c) Solicitar Resonancia Magnética Nuclear de mamas ✗
- d) Realizar punción con aguja fina y citología de la lesión ✗
- e) Realizar biopsia estereotáxica ✗

26) Una mujer de 34 años presenta metrorragia abundante. Recientemente fue diagnosticada de hipertiroidismo, por lo que está tomando propranolol. Se solicita un test de embarazo, que resulta positivo. El diagnóstico más probable es:

- a) Struma ovari
- b) Embarazo ectópico
- c) Enfermedad de Basedow-Graves —
- d) Hiperplasia endometrial
- e) Embarazo molar

27) Una paciente de 35 años consulta por dismenorrea de 6 meses de evolución, que ha ido en aumento. Además, refiere que no ha podido embarazarse, a pesar de llevar más de un año intentándolo. Su examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Miomatosis uterina
- b) Dismenorrea primaria
- c) Anovulación crónica
- d) Adenomiosis
- e) Endometriosis ✓

28) Una paciente, cursando un embarazo de 30 semanas, presenta metrorragia escasa, sin otras alteraciones. Se realiza una especuloscopia, que confirma que la sangre proviene de la cavidad endometrial. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea de urgencia
- b) Administrar corticoides endovenosos y mantener una conducta expectante —
- c) Solicitar ecografía obstétrica *
- d) Solicitar niveles plasmáticos de beta-HCG ✓
- e) Indicar reposo y observar evolución

29) Una paciente de 26 años consulta por hipermenorrea importante. Además, ha presentado dos abortos en los últimos dos años, por lo que no tiene hijos, a pesar de querer tenerlos. Se solicita una ecografía transvaginal, que muestra un mioma submucoso de 3 cm de diámetro, en el fondo uterino. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Indicar anticonceptivos orales
- c) Indicar tratamiento con análogos de GnRH por un año y reevaluar
- d) Realizar miomectomía histeroscópica
- e) Realizar histerectomía

30) Una paciente de 24 años, primigesta, cursando un embarazo de 35 semanas, consulta por contracciones uterinas. Al examen físico presenta una dinámica de 2 contracciones cada 10 minutos y se palpa dilatación cervical de 2 cm. El perfil biofísico es tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar a evolución espontánea
- b) Iniciar progesterona endovaginal
- c) Administrar corticoides endovenosos y tocolíticos ✓
- d) Administrar tocolíticos endovenosos
- e) Iniciar oxitocina en goteo

31) Una mujer presenta un aborto espontáneo hace 4 meses. Desde entonces ha utilizado anticonceptivos orales, sin embargo, no ha tenido menstruación. Se solicita un test de embarazo que resulta negativo y la ecografía transvaginal muestra endometrio fino. El diagnóstico más probable es:

- a) Embarazo ectópico ✗
- b) Sinequias uterinas ✗
- c) Endometriosis ✗
- d) Atrofia endometrial por ACO
- e) Neoplasia trofoblástica gestacional HGB (+)

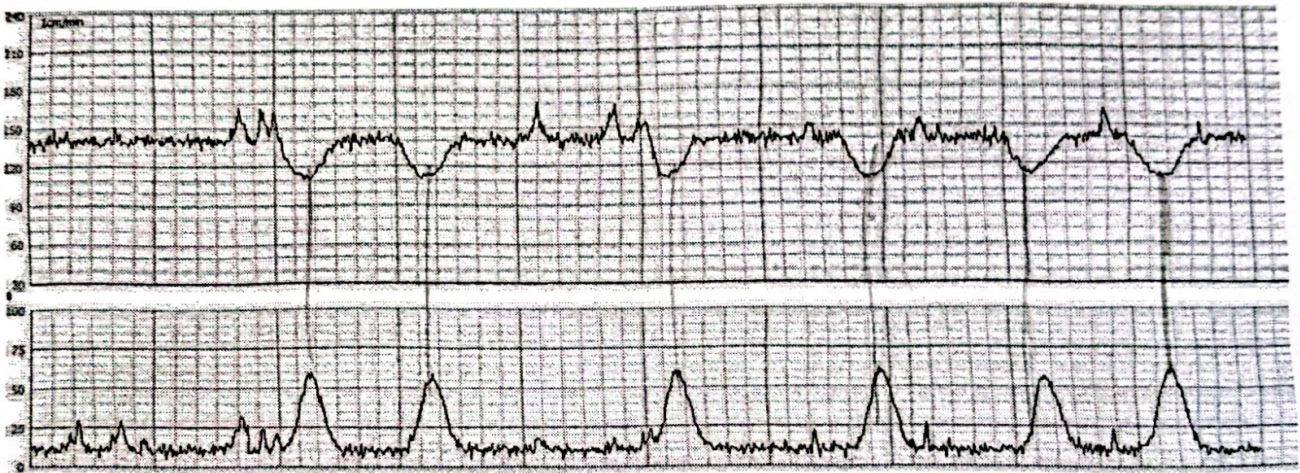
32) Una mujer de 20 años cursando un embarazo de 40 semanas de gestación, inicia trabajo de parto, por lo que es ingresada a la sala de parto, administrándose anestesia raquídea. En una evaluación presenta dilatación completa, con feto en presentación de vértice, en el primer plano de Hodge, con membranas rotas y 1 contracciones cada 10 minutos. El registro fetal es tranquilizador. Se vuelve a evaluar 2 horas después y está en el segundo plano de Hodge. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea
- b) Realizar fórceps
- c) Iniciar goteo oxitócico
- d) Administrar metilergonovina
- e) Mantener conducta expectante

33) Una pareja consulta porque no ha podido concebir un hijo, luego de un año de intentarlo. No utilizan ningún tipo de anticonceptivo y mantienen relaciones sexuales con regularidad, sin embargo, no han logrado ningún embarazo. Él no refiere ninguna patología previa y su examen físico es normal. Ella refiere tener reglas irregulares, que en promedio suceden cada 60 días y al examen físico se aprecia obesa, con algún grado de hirsutismo. ¿Cuál es la causa más probable de la infertilidad en esta pareja?

- a) Anovulación
- b) Alteraciones tubo-peritoneales
- c) Endometriosis
- d) Alteración del factor masculino
- e) Esta pareja es normal y no tiene diagnóstico de infertilidad

34) Durante un trabajo de parto se realiza monitorización de la frecuencia cardíaca fetal. Se aprecia lo siguiente (fuente:):



La conducta más adecuada es:

- a) Dejar a evolución espontánea
- b) Iniciar aceleración oxitócica
- c) Administrar tocolíticos
- d) Realizar rotura artificial de membranas
- e) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita

35) Una mujer con 35 semanas de gestación acude a control, porque ha notado una disminución en los movimientos fetales y está preocupada. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar un registro basal no estresante de la frecuencia cardíaca fetal
- b) Realizar un perfil biofísico
- c) Realizar un test de tolerancia a las contracciones
- d) Realizar una ecografía doppler umbilical
- e) Realizar una ecografía doppler de arterias uterinas

36) Una paciente de 23 años, cursando su primer embarazo de 16 semanas, consulta por metrorragia de un día de evolución. La especuloscopia muestra sangre escasa saliendo por el orificio cervical externo, por lo que se realiza ecografía que muestra feto vivo, con movimientos fetales y latidos a 140 x', sin alteraciones del amnios ni placenta. Además, se observa el cuello uterino cerrado, con longitud de 29 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Administrar tocolíticos
- b) Administrar corticoides ✗
- c) Indicar progesterona endovaginal ✓
- d) Realizar cerclaje ✓
- e) Indicar reposo y controlar ambulatoriamente o SOS

37) Una paciente de 25 años, con antecedente de síndrome de ovario poliquístico, consulta por leve mastalgia bilateral, asociada escasa secreción por ambos pezones. Además, nota aumento de la pigmentación de las aréolas y pezones. Refiere que sus reglas ocurren cada 2 a 3 meses y que la última fue hace 2 meses y medio. ¿Qué examen es más adecuado para el estudio de esta paciente?

- a) Niveles plasmáticos de prolactina
- b) Ecografía mamaria
- c) Niveles plasmáticos de progesterona, LH y FSH
- d) Niveles plasmáticos de gonadotropina coriónica -
- e) Resonancia magnética nuclear de silla turca

38) Una paciente de 34 años, con antecedente de dislipidemia, decide implantarse un DIU (T de cobre) como método anticonceptivo. Sin embargo, presenta dismenorrea e hipermenorrea, en los meses siguientes. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Agregar anticonceptivos combinados ✗
- b) Agregar anticonceptivos con estrógeno solo
- c) Retirar el DIU e implantar un DIU medicado con levonorgestrel
- d) Agregar anticonceptivos con progestágeno solo
- e) Explicar que son síntomas transitorios, agregar ácido mefenámico SOS y observar evolución

39) Una paciente de 17 años consulta por amenorrea de 4 meses de evolución. Su examen físico no muestra alteraciones. Se realiza exámenes, que muestran test de embarazo negativo, TSH y prolactina dentro de rangos normales. Se solicita prueba de progesterona, que resulta negativa y prueba de estrógeno y progesterona, que resulta positiva. Además, se solicita LH y FSH, que están elevadas. El diagnóstico más probable es:

- a) Macroadenoma hipofisiario ✗
- b) Falla ovárica primaria
- c) Embarazo ectópico ✗
- d) Amenorrea hipotalámica
- e) Síndrome de ovario poliquístico

E + P (+) LH FSH
E + P (-)

falla ovarica
SOP

40) Una paciente de 30 años, con antecedente de abscesos a repetición de la glándula de Bartholino derecha, que han sido drenados mediante punción o incisión, consulta nuevamente por dolor vulvar. Al examen físico se aprecia aumento de volumen, de 5 cm de diámetro, doloroso a la palpación, en relación a la zona posterior del labio mayor derecho. La conducta terapéutica más adecuada es:

- a) Cistectomía de Bartholino
- b) Drenaje por punción
- c) Drenaje quirúrgico simple
- d) Iniciar antibióticos orales y esperar el drenaje espontáneo
- e) Bartholinoneocistostomía (marsupialización)

41) Una paciente de 34 años, cursando embarazo de 32 semanas inicia prurito de palmas y plantas, que es más intenso en la noche y se asocia a astenia y vómitos. Al examen físico tiene signos vitales normales y se constata leve ictericia de escleras, sin alteraciones en las extremidades ni lesiones cutáneas. Su altura uterina es de 27 cm. Se solicitan exámenes, entre los que destacan bilirrubina: 1,5 mg/dl, fosfatasa alcalina: 411 UI/L, SGOT: 32 UI/L, SGPT: 38 UI/L, gamaglutamiltransferasa: 398 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a) Colestasia intrahepática
- b) Síndrome de HELLP
- c) Ictericia por hiperémesis gravídica
- d) Hígado graso agudo del embarazo
- e) Embarazo normal

42) Una paciente de 32 años, cursando un embarazo de 33 semanas, consulta por malestar general, asociado a dolor en el epigastrio e hipocondrio derecho de 3 días de evolución, que ha aumentado. Además, tiene astenia, cefalea y náuseas, asociadas a algunos episodios de vómitos alimentarios. Su examen físico muestra FC: 67x', PA: 120/80 mmHg, edema de extremidades inferiores y abdomen doloroso en el hipocondrio derecho, palpándose el hígado bajo el reborde costal. Entre sus exámenes destacan glicemia: 58 mg/dl, creatinina plasmática: 1,3 mg/dl, hemoglobina: 10,6 g/dl, plaquetas: 110.000 por mm³, LDH: 420 UI/L, PCR: 3 (VN: menor a 1), bilirrubina: 2,8 mg/dl, SGPT: 260 UI/L y SGOT: 340 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome de HELLP
- b) Hepatitis viral
- c) Hígado graso agudo del embarazo
- d) Colestasia intrahepática del embarazo
- e) Coledocolitiasis

43) Una mujer de 40 años, cursando su cuarto embarazo, de 40 semanas, inicia trabajo de parto, con feto en presentación cefálica. Mientras estaba en fase de expulsivo inicia dolor abdominal intenso, asociado a metrorragia escasa. Además, se constata cese de las contracciones uterinas. Su embarazo actual no tuvo complicaciones y su parto anterior fue por cesárea, debido a presentación podálica. Se constata que el registro cardiotocográfico muestra una frecuencia cardíaca fetal basal a 60x'. El diagnóstico más probable es:

- a) Rotura de vasa previa
- b) Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera
- c) Acretismo placentario
- d) Placenta previa
- e) Rotura uterina

44) Usted recibe a una mujer de 25 años, ya que se realizó un test de embarazo, que resultó positivo. Refiere que su última regla fue hace 8 semanas y que normalmente ocurren cada 6 a 8 semanas. ¿Cuál es la conducta más adecuada para determinar la edad gestacional es esta paciente?

- a) Determinar niveles plasmáticos de subunidad beta-HCG
- b) Realizar una ecografía transvaginal de inmediato
- c) Utilizar como referencia la fecha de la última regla
- d) Utilizar como referencia la fecha en que se tomó la prueba de embarazo
- e) Realizar una ecografía obstétrica a las 20 semanas de amenorrea

45) Una mujer se realiza un test de embarazo, el que resulta positivo. Acude a su primer control obstétrico, donde se realiza una ecografía transvaginal, que no visualiza el saco gestacional. Se solicitan niveles plasmáticos de gonadotropina coriónica, que resultan 1.000 U/L. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio, indicando reposo y mantener los controles normales del embarazo
- b) Indicar metotrexato
- c) Realizar legrado uterino
- d) Solicitar nueva ecografía en 10 días
- e) Repetir la ecografía y la beta-HCG en 48 horas ✓

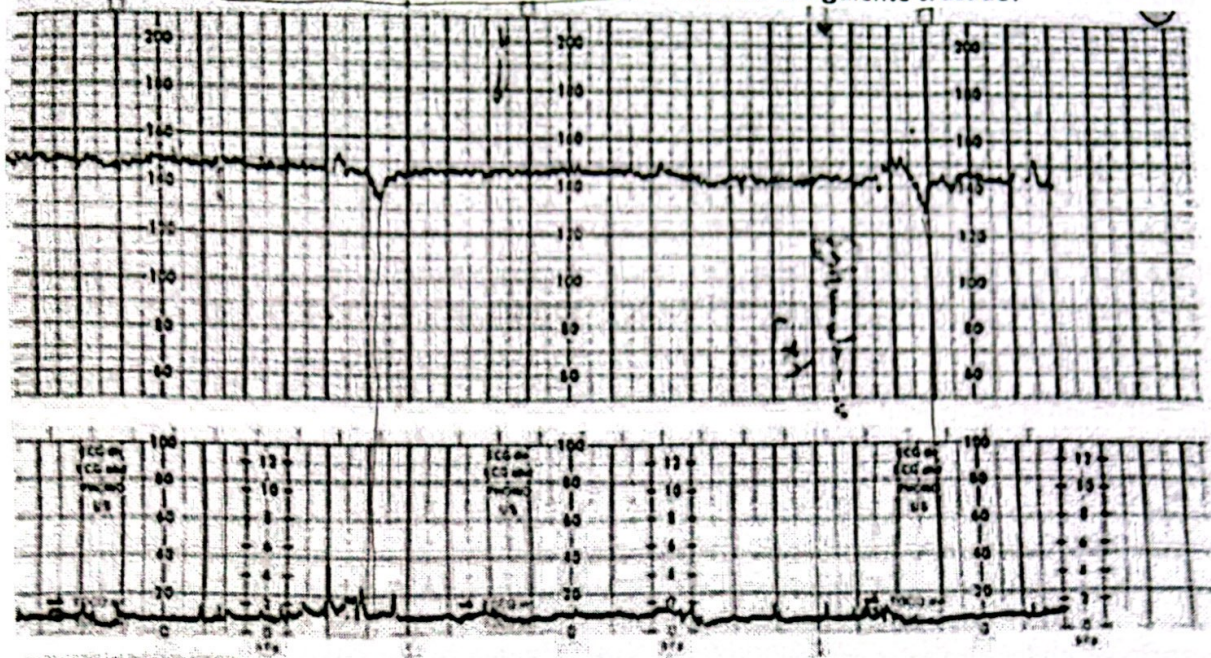
46) Una mujer cursa un embarazo de 38+4 semanas, con buen control prenatal, sin complicaciones. Se realiza una fetometría, que muestra un feto de 4.000 g. Su test de tolerancia a la glucosa oral es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Inducir el parto con misoprostol
- c) Realizar cesárea
- d) Iniciar dieta y ejercicio
- e) Iniciar insulina

47) Una paciente está en trabajo de parto, a las 38 semanas. Presenta 4 CU en 10 minutos, feto en cefálica, con membranas íntegras, 6 cm de dilatación, borramiento completo y descenso en espinas -2. El registro fetal es tranquilizador (MEFI 1). Usted la evalúa 2 horas después y persiste sin cambios. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Realizar rotura de membranas
- c) Iniciar oxitocina en goteo endovenoso
- d) Realizar fórceps
- e) Realizar cesárea

48) Una mujer de 20 años, cursando un embarazo de 40 semanas de edad gestacional, se realiza un registro basal no estresante, por 20 minutos, que muestra el siguiente trazado:



La conducta más adecuada es:

- a) Interrumpir el embarazo
- b) Observar evolución
- c) Solicitar un perfil biofísico
- ☒ d) Solicitar un test de tolerancia a las contracciones
- e) Alargar el registro basal no estresante por 20 minutos más

49) Una mujer de 23 años, cursando un embarazo de 30 semanas, se realiza una ecografía, que muestra la presencia de una placenta previa que cubre completamente el orificio cervical interno.

La conducta más adecuada es:

- a) Interrumpir el embarazo, induciendo con misoprostol
- ☒ b) Administrar corticoides y mantener una conducta expectante
- c) Realizar cesárea de urgencia
- d) Realizar amniocentesis
- e) Observar evolución e inducir con misoprostol a las 37 semanas

50) Una mujer de 34 años presenta un embarazo de 34 semanas. Se realiza una ecografía obstétrica, que demuestra un feto con un peso en percentil 3 para la edad gestacional, con normalidad en el líquido amniótico. El registro basal no estresante no muestra alteraciones. ¿Qué conducta es más adecuada para el manejo de esta paciente?

- a) Interrupción por la vía más expedita
- b) Inducción del parto con misoprostol
- c) Solicitar un doppler de arterias uterinas
- d) Administrar corticoides y tocolíticos a la madre
- ☒ e) Solicitar un doppler fetal

51) Una paciente múltipara, cursando un embarazo de término, inicia trabajo de parto, en fase de expulsivo, con feto en presentación de vértice y 4 contracciones cada 10 minutos. Como antecedente tiene una cesárea previa a las 36 semanas. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea ✗
- b) Dejar evolución espontánea ✓
- c) Realizar fórceps
- d) Administrar tocolíticos
- e) Administrar corticoides y tocolíticos

52) Una mujer de 30 años consulta por leucorrea, abundante y disuria. Al examen físico se aprecia mucosa vulvar y vaginal eritematosa, con cuello uterino con abundantes petequias y leucorrea verde abundante. Además, presenta mal olor. La etiología más probable del cuadro descrito es:

- a) Parasitaria
- b) Bacteriana
- c) Obstrucción al tracto genital
- d) Tumoral
- e) Funcional

53) Una niña de 12 años refiere que sus reglas son muy abundantes, con coágulos en algunas ocasiones y que vienen regularmente cada 28 días, desde hace 1 año. Ha sido tratada por anemia ferropénica y se realizó una exploración clínica ginecológica, que mostró himen perforado, sin alteraciones en los genitales externos, así como una ecografía transrectal, que fue normal. ¿Qué conducta es más importante dentro de los enumerados?

- a) Realizar biopsia endometrial
- b) Realizar PAP y colposcopia ✗
- c) Solicitar pruebas de hemostasia
- d) Realizar cultivos vaginales
- e) Iniciar ACO

54) Una paciente con antecedente de SOP, presenta metrorragia en 2 oportunidades. Al examen físico se palpa útero aumentado de tamaño y la ecografía transvaginal muestra un endometrio engrosado, irregular. El diagnóstico más probable es:

- a) Adenomiosis
- b) Endometriosis
- c) Miomatosis
- d) Neoplasia trofoblástica gestacional ✓
- e) Cáncer de endometrio ✗

55) En un control, una mujer de 60 años se realiza una ecografía transvaginal, que muestra la presencia de un tumor anexial derecho de 7 cm de diámetro, de aspecto quístico, con presencia de varias increscencias y escasa ascitis. El diagnóstico más probable es:

- a) Endometrioma
- b) Quiste folicular
- c) Cuerpo albicans
- d) Teratoma quístico
- e) Cistoadenocarcinoma

56) ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación del uso de ACO?

- a) Antecedentes familiares de cáncer de endometrio
- b) Antecedentes familiares de cáncer de ovario
- c) Antecedentes familiares de cáncer de mama
- ☒ d) Jaqueca con aura, luego del inicio de ACO
- e) Síndrome de ovario poliquístico

57) Una mujer de 30 años consulta por leucorrea y dolor abdominal bajo. Al examen físico se aprecia mucosa vulvar y vaginal normales, con escasa leucorrea que proviene del OCE. Además, presenta dolor a la palpación anexial y a la movilización cervical. La etiología más probable del cuadro descrito es:

- a) Parasitaria
- ☒ b) Bacteriana
- c) Obstrucción al tracto genital
- d) Tumoral
- e) Funcional

58) Una mujer de 40 años está en amenorrea desde hace 5 meses. Se ha realizado varios exámenes entre los que destacan test de embarazo: negativo, TSH: normal, prolactinemia: normal, prueba de progesterona: negativa, prueba de estrógeno más progesterona: positiva y LH/FSH: disminuidas. ¿Cuál es la causa más probable de su amenorrea?

- ☒ a) Anovulación
- b) Alteración uterina
- c) Falla ovárica primaria
- d) Hipotalámica / hipofisiaria
- e) Menopausia normal

BTP (+)
LH FSH ↓

LH FSH ↑
menopausia

59) Una mujer de 56 años se realiza una biopsia endometrial, que demuestra presencia de hiperplasia endometrial simple, sin atipias. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar estrógenos locales
- ☒ b) Indicar progestágenos
- c) Solicitar niveles plasmáticos de beta-HCG
- d) Realizar legrado uterino
- e) Realizar histerectomía total

60) Una niña de 5 años presenta metrorragia de mal olor. Al examen físico se aprecia secreción hemopurulenta que proviene de la vagina. El diagnóstico más probable es:

- a) Himen imperforado complicado
- b) Abuso sexual
- c) Vulvovaginitis inespecífica
- ☒ d) Cuerpo extraño vaginal
- e) Cáncer de vagina